

SCANNER & IRM VAL DE LOIRE

Centre d'Imagerie Médicale
12 avenue du Général Leclerc
37000 TOURS
Résultats : imagerie-valdeloire.fr
Téléphone : 02.47.00.00.00

Nom : MARTIN
Prénom : Julien
Date de naissance : 03/11/1975
Sexe : M

Tours, le 15/03/2026
Dr Claire ROBERT
Médecin radiologue

SCANNER ABDOMINO-PELVIER

Indication:

Douleurs abdominales localisées en fosse iliaque gauche évoluant depuis plusieurs jours, associées à une fièvre modérée et un syndrome inflammatoire biologique. Suspicion clinique de diverticulite.

Technique:

Acquisition volumique hélicoïdale abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisition au temps portal. Reconstructions multiplanaires dans les plans axial, sagittal et coronal. Analyse en fenêtres parenchymateuse, digestive et osseuse.

Résultats :

À l'étage thoracique (partiellement exploré) :

Bases pulmonaires correctement expansées.
Absence de foyer de condensation ou d'infiltrat parenchymateux basal.
Pas d'épanchement pleural visualisé.
Pas d'anomalie des coupes diaphragmatiques.
Contours cardiaques dans les limites de la normale sur les coupes analysées.
Absence d'adénopathie médiastinale basse visualisée sur les champs explorés.

À l'étage abdomino-pelvien :

Côlon et structures digestives :
Épaississement pariétal circonférentiel du côlon sigmoïde sur un segment d'environ 5 à 7 cm, avec rehaussement après injection.

Présence de diverticules multiples sur ce segment, certains inflammatoires.
Infiltration de la graisse péri-colique adjacente avec aspect de stranding inflammatoire.
Présence d'une petite collection péri-sigmoïdienne, bien limitée, mesurant environ 15 à 20 mm, évoquant un abcès en constitution.
Absence de pneumopéritoine visualisé.
Pas d'occlusion intestinale en amont.

Foie et voies biliaires :

Foie de taille normale, contours réguliers, densité homogène.
Pas de lésion focale suspecte.
Voies biliaires non dilatées.
Vésicule biliaire fine, sans lithiasse visible ni signe d'inflammation.

Pancréas :

Pancréas de morphologie et de densité normales.
Pas de dilatation du canal pancréatique principal.

Rate :

Rate de taille normale, homogène.

Surrénales :

Surrénales fines, sans anomalie détectable.

Reins et voies urinaires :

Reins de taille et morphologie normales.
Différenciation cortico-médullaire conservée.
Absence de lithiasse ou de dilatation des cavités pyélocalicielles.
Pas d'anomalie urétérale visible.

Vaisseaux :

Axes vasculaires abdominaux de calibre normal.
Pas d'anévrisme ni de thrombose détectée.

Aires ganglionnaires :

Pas d'adénopathie coelio-mésentérique ou lombo-aortique significative.

Cavité péritonéale :

Pas d'épanchement péritonéal libre significatif.
Pas de signe de carcinose.

Structures osseuses :

Structures osseuses analysées sans anomalie suspecte.
Pas de lésion lytique ou condensante.

Conclusion :

Aspect tomодensitométrique en faveur d'une diverticulite sigmoïdienne aiguë compliquée, caractérisée par un épaississement pariétal du sigmoïde associé à une infiltration de la graisse

péri-colique et à une petite collection péri-sigmoïdienne (15–20 mm) compatible avec un abcès en formation.

Absence d'argument en faveur d'une complication sévère immédiate :

- pas de pneumopéritoine,
- pas d'occlusion digestive,
- pas d'épanchement péritonéal significatif.

Le reste du bilan abdomino-pelvien est sans anomalie notable, notamment absence de lésion hépatique ou d'adénopathie suspecte.

Ensemble compatible avec une diverticulite compliquée localisée (stade Hinchey Ib).

Recommandations :

Prise en charge médico-antibiotique adaptée avec surveillance clinico-biologique. Un contrôle scanographique secondaire pourra être discuté en fonction de l'évolution, notamment pour vérifier la régression de la collection.